

8 - 02- Les Cancers du Cavum - Pr. ROCHDI

On va continuer dans la pathologie cancéreuse OAM. On a vu la dernière fois le cancer du larynx. Aujourd'hui, on va voir les cancers du cabin.

Le cancer du cabin, qui constitue un problème de santé au Maghreb et en Asie du Sud-Est. Il a certaines particularités. D'abord, le siège qui est profond sous la base du crâne.

Le plavum, ou bien le rhinopharynx, siège sous la base du crâne, derrière les fosses nasales. Ce qui fait que le diagnostic reste en général tardif. Puisque l'accès et l'examen de cette région sont un peu difficiles cliniquement.

Et on doit céder par endoscopie. Chose qui n'est pas toujours disponible. Deuxième particularité, c'est les facteurs de risque qui sont différents.

Par rapport aux autres cancers des voies aérodigestives supérieures. Là, il y a l'incrimination de l'Epstein-Barr, cofacteur de risque. Surtout pour le type indifférencié.

Et c'est celui qu'on va étudier aujourd'hui le plus. Les rapports du cabin sont très importants. Avec la base du crâne, avec les autres structures qu'on va voir.

Ce qui fait que la symptomatologie, par l'atteinte de ces rapports, va être riche. Quatrième particularité, c'est concernant le type histologique le plus fréquent. C'est ce qu'on appelle le carcinome indifférencié.

De type masopharingé. C'est le type histologique le plus fréquent. Et chose qui est très bonne concernant ce carcinome, c'est qu'il est chimiosensible et surtout radiosensible.

Ce qui fait que dans les formes qui sont diagnostiquées de façon précoce, le pronostic peut être meilleur. Alors, concernant l'épidémiologie des cancers du cabin. C'est une pathologie qui est fréquente au Maroc.

Mais il faut savoir que l'épidémiologie est variable dans le monde. C'est-à-dire qu'on reconnaît des zones de haut risque. Et c'est exactement en Asie du Sud-Est.

Et puis, il y a les zones où le risque est moyen. C'est les pays du Maghreb dans le Maroc. Où l'incidence peut atteindre jusqu'à 3,2 personnes sur 100 000.

Et puis, il y a les zones de risque faible. Tels les Etats-Unis, le Japon et l'Europe. Alors, particularité aussi de ces cancers du cabin, c'est qu'on a deux pics de fréquence.

Le premier pic, c'est entre 10 et 24 ans. Et le deuxième, à un âge beaucoup plus éloigné, c'est autour de 50 ans. Et sur le plan de la prédominance du sexe, il y a une prédominance masculine qui est supérieure à celle de la fréquence chez la femme.

Là, c'est une carte qui montre un petit peu les différentes zones d'Andalucía. En noir, vous voyez les zones de haut risque. C'est l'Asie du Sud-Est.

Et puis, vous voyez ici les zones d'incidence où le risque est moyen. C'est le pourtour méditerranéen, c'est ouvert vers les pays du Maghreb. Et puis, vers le Japon, l'Europe éventuellement.

Là, ce sont des zones qui sont de risque faible. Alors, toujours concernant l'épidémiologie de ce cancer du cavum, il est à noter qu'il y a comme facteur de risque l'Epstein-Barr virus. L'Epstein-Barr virus est un virus à ADN qui fait partie des herpès virales.

Et ça a été confirmé par la mise en évidence du gélant viral dans les cellules tumorales. Donc, cette infection par ce virus va entraîner une réaction immunitaire avec l'apparition d'anticorps sous forme d'IgG et d'IgA. Alors, la présence d'anticorps anti-Epstein-Barr virus peut être utilisée dans le suivi de ces patients après le traitement et dans le cadre de la surveillance.

Il y a des facteurs génétiques qui sont aussi notés, qui sont liés au système HLA. Et on a noté qu'en Afrique du Nord, il y a certaines anomalies chromosomiques spécifiques qui sont en rapport avec l'atteinte tumorale au niveau de ces régions du Maghreb. D'autres facteurs environnementaux sont notés.

En premier, c'est l'ingestion de neutrosamines, c'est-à-dire l'alimentation qui est riche en poissons séchés et salés, soit de poissons ou bien de viandes. Au Maroc, c'est surtout le chlére qui se forme de viande qui est surtout séchée et très salée. Donc ce type d'alimentation est très riche en neutrosamines et constitue un facteur de risque d'apparition du carcinome du cavum.

L'exposition aux produits de combustion a aussi été notée. D'autres facteurs aussi qui sont à l'ordre professionnel, c'est les industries en matière plastique, de cahots, qui sont caractérisés par une exposition au format libre. Le niveau socio-économique bas est très bien noté, si je suis patient.

Il faut noter que les enfants, les adultes qui ont passé une enfance dans un lieu à haut risque, ils gardent un risque élevé, c'est-à-dire un risque qui est équivalent aux personnes qui sont encore vivantes dans les zones endémiques de risque élevé. C'est-à-dire que ces patients gardent toujours un risque élevé d'avoir un carcinome du cavum. Avant de parler de l'anatomopathologie, on va faire un petit rappel anatomique sur le cavum.

Ce n'est pas le cavum, le cavum fait partie des bois aériennes supérieures. Elle est située derrière les fosses nasales, ça c'est les fosses nasales, ça c'est le cavum, derrière les fosses nasales, au-dessus de l'oropharynx, au-dessous de la base du crâne, donc l'étage moyen et l'étage antérieur, et en avant de la charnière crânio-cervicale, en arrière. Donc ça c'est les limites du cavum, on vient du rhéumopharynx, qui est appuissé par une muqueuse aussi, par l'expiratoire, et on note la présence d'organes lymphoïdes de façon très importante, puisque le

cavum fait partie de l'anneau de Valdée, qui dit anneau de Valdée, c'est-à-dire une richesse en organes lymphoïdes, et on note, au niveau de ces parois latérales, la présence de l'orifice rhéumopharyngé de la trombe de Stache, qu'on voit ici.

Ici on a l'orifice de la trombe de Stache, avec le torus suivant, et derrière cet orifice, il y a ce qu'on appelle la fossette d'orosine nulla. Alors pourquoi on insiste sur la fossette d'orosine nulla ? Dans ce cas-là, c'est parce que ça va constituer le point de départ principal où va apparaître en général le cancer du cavum. Donc là, c'est un autre schéma qui montre un petit peu la même chose.

Donc, quels sont les rapports ? Les rapports du cavum ici, donc en avant, il y a les fosses nasales, à travers les coins. En arrière, c'est l'orifice cervical, avec les muscles pré-vertébraux, avec la partie inférieure du corps suivant, donc l'orifice cervical. En bas, à travers l'isthme pharyngonasal et le voile du palais, il y a une communication avec l'oropharynx.

Et en haut, il y a le corps du suivant, avec le sinus suivant, l'acèle tirsique, le sinus canverneux de part et d'autre, et en haut, la région paracélaire, avec, en avant toujours, et latéralement, il y a les apexes orbitaires, les espaces parapharyngiques, qu'on va voir à ce niveau-là. Donc là, latéralement, on voit les espaces parapharyngiques qui font partie de la force infratemporelle, avec la présence de l'espace masticateur, avec le muscle pterygimien latéral, le muscle pterygimien médial, avec le nerf mandibulaire, qui est un nerf qui va innerver le muscle masticateur. Et plus en dehors, on a l'espace pré- et rétro-obsidien avec la région paroxydienne.

Donc ça, c'est les principaux rapports que présente le cavant, on dirait, le rayon pharynx. Le drainage lymphatique, il faut retenir, c'est un drainage lymphatique qui est croisé, ça veut dire qu'il va se faire dans les deux côtés, à droite et à gauche, et le premier relais siège au niveau rétro-pharyngeal, au niveau des gonglions rétro-pharyngeal, après le drainage, va se faire vers les gonglions jugés de paroxydien, c'est-à-dire le groupe 2, 3, 4 et 5. Donc le drainage lymphatique, il est bilatéral, croisé, et il faut savoir que, puisqu'il y a une richesse en organes fluides, ce qui fait que les cancers du cavant vont être très très très lymphophiles, et de ce fait, parfois, on a des cancers qui apparaissent d'emblée avec, qui sont diagnostiqués d'emblée avec des métastases gonglionnaires. Ça c'est une vue endoscopique du cavant, donc vous voyez ici la cloison nasale, l'orifice de la trombe de Stach, avec le thorax cul-vert, c'est la lèvre postérieure de l'orifice cul-vert, et ici la fossette de Rosen, du vert, avec la paroi postérieure, la paroi supérieure du cavant, avec la reliquat de végétation adhénié, et au-dessous, vous voyez le voile du palais, avec la communication vers le bas, avec l'orphanax.

Ça c'est, même vue endoscopique, un peu loin, on voit très bien au fond le cavant, avec cet orifice-là, qui constitue la coine, ça c'est le septum nasale, vous voyez très bien en profondeur, sur la paroi postérieure du cavant, la reliquat de végétation, adhénié, qui sont très riches en organes confluides. Alors, sur le plan anatomopathologique, le point de départ, comme on l'a vu, sur la fossette de Rosen, du vert, c'est-à-dire sur la paroi latérale du cavant, macroscopiquement,

c'est des tumeurs qui sont bourgeonnantes, qui sont ulcérées, infiltrantes, parfois ulcérant-infiltrantes, qui sont friables, qui peuvent saigner facilement. Sur le plan microscopique, il y a différents types d'histologie qu'on peut avoir, il y a le carcinome, il y a les lymphomes, les adénocarcinomes, les sarcomes, les mélanomes, mais le type histologique le plus fréquent, c'est le carcinome.

Le carcinome, c'est le type le plus fréquent des cancers du cavant, et c'est lui qu'on va traiter aujourd'hui, puisque c'est la forme la plus fréquente, et il répond très bien au traitement, c'est le diagnostic de façon précoce. Alors, toujours dans le carcinome, on distingue le carcinome qui est indifférencié du type masopharyngé, c'est l'UCMP, Undifferentiated carcinoma of masopharyngeal type, qui constitue 70%, et puis il y a les carcinomes qui sont peu différenciés ou bien différenciés. Alors, le premier, l'indifférencié est beaucoup plus fréquent chez le sujet jeune, chez l'enfant, qui est en rapport avec l'infection à l'épithéliomyelose, et puis le carcinome bien différencié, qui est l'apanage du sujet âgé, lui, il est en général en rapport avec une contamination, avec une exposition au phénomène du au tabac.

Et puis, il y a d'autres types histologiques, le maintien des carcinomes, qu'on verra éventuellement dans d'autres cours, puisqu'on les a cités juste ici pour vous sachez qu'on a plusieurs types histologiques, et que c'est le carcinome qui est le plus fréquent. Alors, l'immunochimie permet parfois de poser des diagnostics, vu qu'on est devant un carcinome qui est indifférencié, on est obligé d'utiliser des marqueurs immunohistochimiques pour pouvoir trancher et confirmer les diagnostics, et pouvoir trancher entre l'infant et le carcinome indifférencié. Alors, qu'en est-il de l'extension locale ? L'extension peut se faire en avant vers les cônes et les fosses nasales, et ça va être responsable d'une obstruction nasale unie ou bilatérale.

On peut avoir une extension toujours en avant vers l'orbite, lorsqu'on aura un syndrome des apexes orbitaires, avec exophtalmie, atteinte d'urgence au kilomètre. On peut avoir une extension postérieure, en premier vers les espaces rétropharyngés, voire même une atteinte des muscles pré-vertébraux, et une atteinte même d'urarchie syndicale. Latéralement, où il y a les orifices tubaires sur la paroi latérale, on peut avoir une extension vers la trombe de Stach, une infiltration vers la trombe de Stach, et dans ce cas-là, on aura un problème de dysfonctionnement tubaire qui va se manifester par une hypoacousie, des otalgies, des aspects d'otites céromiqueuses à l'examen orthoscopique.

Et si l'extension se prolonge latéralement, on pourra avoir une atteinte de la fosse infratemporale, avec une atteinte de l'espace masticateur, des muscles masticateurs, des ptérygiens latéral, des ptérygiens médial, voire même une atteinte d'une aire mandibulaire, c'est le sein 3, et dans ce cas-là, on aura des difficultés à l'ouverture de la bouche, des limitations, voire un trismus, c'est-à-dire une limitation de l'ouverture de la bouche. On peut avoir une extension inférieure, une extension inférieure vers le voile du palais, une extension inférieure qui peut se faire le long du pilier postérieur en général pour atteindre la loge amygdalienne, et la paroi postérieure du voile du palais, comme on peut

avoir une extension supérieure, c'est-à-dire une atteinte des sinus fénidales, une atteinte des os de la base du crâne, qui est un facteur de mauvaise performance, avec une atteinte des sinus cavernaux, avec les différents éléments des différents nerfs crâniens qui traversent la base du crâne, on peut avoir une atteinte d'une aire oculomoteur commune, d'une aire oculomoteur externe, on peut avoir même une atteinte au niveau des trous déchirés postérieurs, une atteinte de l'air mixte qui va être responsable du trouble de la déglutition. Bref, l'extension au niveau de la base du crâne, c'est un élément qui n'est pas rare, puisque la mycose, la tumeur n'est pas loin de la base du crâne, donc on peut avoir une extension supérieure et qui assombrit le pronostic.

Puisqu'on a dit que c'est un organe où il y a des éléments linfluides, et qui est caractérisé par la richesse des organes linfluides et la richesse du drainage lymphatique, les métastases ganglionnaires sont fréquentes, ils sont souvent bilatérales, et même les métastases à distance ne sont pas rares, mais on peut avoir des métastases osseuses, ou bien au niveau des poumons. Alors, comment ce cancer du cavernes va-t-il se manifester ? Dans la clinique, dans les signes fonctionnels du cancer du cavernes, on caractérise quatre syndromes. D'abord le syndrome ganglionnaire, et ce syndrome et ses syndromes, on peut les avoir, les rechercher, et les retrouver.

Parfois, le patient vient consulter pour l'un des signes. C'est-à-dire qu'il vient consulter pour un adénopathie cervicale, il vient pour des autalgies, des acouphènes, une inutile de l'oreille, etc. Ce qu'on appelle les signes d'appel.

Et il faut savoir, devant ces signes d'appel, penser à une pathologie au niveau du rhinopharynx et faire des examens endoscopiques à dépôt. Les adénopathies jugulocarotidiennes hautes en général, dans le cancer du cavernes, c'est-à-dire des métastases unilatérales ou même bilatérales, se forment d'adénopathies jugulocarotidiennes hautes qui sont un petit peu postérieures à l'être humain régulière, sous-mastomédien, dégaube, sous-digastrique, et spinale supérieure. Ce sont des adénopathies qui sont volumineuses, qui sont dures, parfois elles sont fixées.

On peut avoir des adénopathies hautes ou bien même des adénopathies au niveau fusclaviculaire, qui est un élément de très mauvais pronostic. Le syndrome ontologique, lui, il est constitué par la sensation de plénitude de l'oreille, une épaule acrosie, des acouphènes, unilatéraux en général, ou bien des otalgies. Le troisième syndrome, c'est le syndrome rhinologique, l'extension antérieure de la tumeur va être responsable de l'obstruction nasale, unilatérale, des épistaxis récidivantes, ou bien des modifications de la voie sous forme d'une rhinopharyngee fermée, c'est-à-dire une modification de la voie en rapport avec un problème au niveau rhinopharyngee, et surtout une obstruction rhinopharyngee, on appelle ça une rhinopharyngee fermée.

Le quatrième syndrome, c'est le syndrome neurologique, d'où l'intérêt de faire un examen neurologique, et surtout de part crânienne, devant tout patient qui a l'indice qu'on vient de citer,

le syndrome gonglionnaire, le syndrome ontologique, le syndrome rhinologique, devant des céphalées rebelles, devant des névralgies faciales qui sont rebelles aux traitements médicaux, devant une paralysie oculomotrice, telle celle qu'on voit ici sur la photo, où on a une abduction du globe oculaire gauche, une paralysie oculomotrice qui peut toucher soit la sixième paire crânienne ou bien la troisième paire crânienne, il peut être responsable d'un strabisme, ou bien parfois même d'un ptosis. Le patient peut consulter pour un trismus, responsable d'une atteinte soit de l'espace masticateur par la tumeur, ou bien par une atteinte du sein, en l'occurrence du sein 3, de manière monogulaire. Alors ces 4 syndromes, les signes de ces 4 syndromes peuvent être associés de façon variable en fonction de l'extension tumeur.

Alors devant ces signes cliniques, il faudra commencer par faire une nasophibroskopie, ou bien, si on dispose pas d'un nasophibroskop, faire une rhinoskopie postérieure. La rhinoskopie postérieure se fait à l'aide d'un miroir qu'on introduit derrière, au niveau de l'oropharynx, un peu derrière le voile du palais, pour voir le cavon, en général une image plus inversée, mais ça peut nous montrer l'orinopharynx avec l'équine, éventuellement la tumeur s'il est présente. Mais la nasophibroskopie reste l'examen de choix, c'est un fibroskop qu'on va introduire par le nez, et qui va nous montrer le siège de la tumeur, la taille, l'aspect, l'extension à la fosse nasale, ou bien à l'oropharynx.

En même temps, on verra si c'est une tumeur plus infiltrante, plus ulcérée, plus bourgeonnante, choses qui vont nous orienter vers une tumeur probablement maligne. L'otoskopie peut nous montrer une antiséroneuse avec des bulles d'air, ou bien des niveaux hydroaériques derrière le tampon qui témoignent d'un épanchement, parfois même une rétraction d'un panache, mais il faut savoir que parfois, l'examen otoscopique est normal, même en présence d'une tumeur du cas-là. Ça veut dire que la tumeur n'a pas infiltré la trombe de Stach qui reste toujours fonctionnelle dans ce cas-là.

Alors là, c'est la nasophibroskopie, vous voyez ici le médecin qui introduit le nasophibroskop par la narine, vous voyez sur le schéma, on traverse le vestibule nasal, les fosses nasales, on traverse les cônes, et on est au niveau du cavernes, on peut faire l'examen complet du cavernes, trombe de Stach, et même descendre vers le bas pour suivre éventuellement la tumeur, explorer la base de la langue, le larynx, la rectiligne, les portes vocales, etc. Donc là, c'est l'image que nous donne la nasophibroskopie, vous voyez sur la photo ici, vous avez la paroi postérieure du cavernes, latéralement la trombe de Stach, on va le voir du palais, et vers le haut, la paroi supérieure. Et remarquez ici la myoclose qui est pas lénisse, il n'y a pas de lésions ulcérées, pas de lésions tumorales, ça c'est un aspect normal avec des reliquats de végétation adénoïdes qui sont normaux, qui ne sont pas hypertrophiques dans ce cas-là.

Alors ça c'est un exemple de tumeur du cavernes, vous voyez ici sur une fosse nasale gauche, on a introduit la nasophibroskop et voilà ce qu'on voit, ça c'est la cloison nasale, ça c'est le plancher de la fosse nasale, ça c'est le cornet intérieur, et puis on voit une tumeur qui est

bourgeante, qui saigne un petit peu par endroits, avec des limites irrégulières, et qui cambre complètement l'oreille viscoanale, et qui s'étend même au niveau de la fosse nasale. Ça c'est franchement une tumeur très suspecte, et il faudra, une fois qu'on a fait l'imagerie, passer à la biopsy pour, avec une anatomopathologie pour confirmer le diagnostic. Donc ça c'est une image de la nasophibroscope.

L'autre examen qu'on peut faire c'est la laryoscopie postérieure, en introduisant le miroir, où on peut voir la tumeur, avec les deux trembles latéralement, et ça c'est la couronne. Remarquez que l'image ici est inversée. C'est un examen qui est possible, mais qui est un peu difficile, vu que l'examineur est gêné par le réflexe noseilleux que provoque l'introduction du miroir au niveau de l'oropharynx.

Donc là c'est l'examen otoscopique qui peut montrer l'aspect d'autocéromiqueuse, où on voit très bien les niveaux de dents aériques, c'est-à-dire qu'on a un épanchement au niveau de l'oreille moyenne derrière le tympan, avec la présence d'huile d'air. Le patient dans ce cas-là va ressentir une sensation d'oreille bouchée, il va avoir une épine incosie de ce côté-là, parfois des otalgies qui sont minimales. Là c'est la même chose, on voit le patient qui a un épanchement, c'est plein, derrière le tympan, tout est plein de liquide, avec une rétraction tympanique.

Là c'est l'exemple, le type d'hynotite céromiqueuse qui doit nous orienter vers l'atteinte des cavernes, surtout l'osphélée unilatérale. Une fois qu'on a fait l'examen la nasophiloscopie, il faudra faire l'examen otoscopique, il faudra examiner l'oropharynx pour voir s'il y a une extension vers l'oropharynx, est-ce qu'il y a une boussure du voile, est-ce qu'il y a une tumefaction qui s'étend le long du pilier postérieur, est-ce qu'il y a une tumeur obstructive qui risque d'entraîner une gêne respiratoire. On passera à l'examen cervical pour explorer les aires ganglionnaires pour rechercher les adénopathies, est-ce qu'elles sont unilatérales, bilatérales, est-ce qu'elles sont la taille des adénopathies, est-ce qu'elles dépassent 6 cm ou non, pour pouvoir les classer, est-ce que les adénopathies dépassent le niveau du bord inférieur du cartilage oculaire.

On fera l'examen des perles crâniennes, on recherchera surtout une atteinte d'une aire oculomoteure, en explorant l'oculomotricité, en recherchant est-ce qu'on a un strabisme, est-ce qu'on a un ptosis, est-ce qu'il y a une diplopie dans une position de l'œil, est-ce qu'il y a une exophtalmie. On explorera les territoires sensitifs de la face pour voir est-ce qu'on a une atteinte d'ifrégimeaux, est-ce qu'on a une trismyphe ou non. Et on finira par un examen général, un examen stomatologique pour rechercher des caridans d'air à traiter pour préparer éventuellement le patient à une radiothérapie.

On fera un examen pleuropulmonaire et ostéoarticulaire pour rechercher des métastases à distance. Alors ça, c'est des photos qui montrent, par exemple chez ce patient, une adénopathie gégulo-carotidienne haute, vous voyez la taille de l'adénopathie, elle dépasse ici 5 cm, du siège gégulo-carotidien haut. Ce patient-là présente un ptosis de l'oeil gauche en rapport avec une extension à travers la base du crâne, voire même une atteinte au niveau de la pexe orbitaire.

Ce patient-là présente une déviation de la langue à droite lors de la protraction et qui témoigne d'une paralysie de la langue droite. Ce patient-là présente la même chose, un ptosis de l'oeil gauche, l'atteinte de la troisième paire crânienne. Alors, on retiendra comme conclusion de cet état clinique que devant tout patient qui présente une antithrombose unilatérale, une adénopathie cervicale haute, une obstruction nasale unilatérale, une épistaxe récidivante unilatérale, il faudra faire ponctionner un problème au niveau du rhinopharynx et faire obligatoirement une nasopharyngoscopie.

Demandez une nasopharyngoscopie pour être sûr qu'il n'y ait pas de tumeur au niveau du rhinopharynx. Alors, qu'en est-il des examens par clinique ? Alors, première chose lorsqu'on va découvrir une tumeur, le mieux, c'est de faire le couple IRM-Scanner. On demandera une IRM du crâne et de la base du crâne.

L'IRM va nous montrer le siège de la tumeur et surtout l'extension en paranasale, c'est-à-dire l'extension latérale vers les espaces masticateurs, vers la fosse infratemporale. Ainsi que l'extension à travers la base du crâne, c'est-à-dire intracrânienne, l'extension au niveau de l'orbite, etc. Mais pour explorer l'extension osseuse, dans ce cas-là, c'est le rôle du scanner qui permet de montrer l'ostéolyse, qui permet de localiser la tumeur et en même temps montrer l'ostéolyse, qui est un élément, comme on l'a dit, qui est très important.

L'ostéolyse qui va être le témoin de l'extension, soit par exemple au niveau d'orbite, soit une ostéolyse au niveau de la base du crâne, à travers le sillon et à travers parfois le sillon-sillon. Donc une fois l'imagerie est faite, il faudra faire un examen endoscopique, ce qu'on appelle l'arynoscopie. L'arynoscopie, c'est comme la nasopharyngoscopie, sauf que c'est un examen qui se fait avec un endoscope rigide pour pouvoir faire la biopsie.

C'est-à-dire qu'il va nous orienter exactement vers le siège de la tumeur pour faire plusieurs biopsies. Pour faire plusieurs biopsies, une biopsie multiple pour pouvoir augmenter les chances d'avoir un diagnostic positif d'emblée. Donc on peut demander l'histologie anti-Epstein-Barr virus pour pouvoir assurer la surveillance post-thérapeutique.

Alors là, c'est des images scanographiques et DRM chez des patients qui ont un cancer du maxillaire. Vous voyez sur cette photo en haut à gauche, vous avez une coupe axiale d'un scanner de la face qui passe par le sinus maxillaire, la cloison nasale, les fosses nasales et vous avez derrière les maxillaires avec le maxillaire. On remarque que le maxillaire est complètement comblé par un processus tissulaire qui comble les deux maxillaires et qui s'étend même latéralement surtout ici à gauche.

Même chose sur la photo en haut et à droite, on voit que la tumeur remonte à travers la base du crâne et il infiltre le sinus caverneux et il infiltre l'étage postérieur de façon bilatérale et on a même une extension intracrânienne derrière la cellule tire-sucre. Là, ça témoigne et on voit même une extension au niveau de l'apex orbitaire. Ce patient-là doit obligatoirement avoir une

atteinte des paires crâniennes c'est-à-dire une atteinte du 3, une atteinte du 6 et même, je pense, une atteinte d'une aire régimiaux vu l'extension postérieure vers l'apex spectreux.

Là, vous voyez que le scalaire aussi nous permet de montrer qu'il y a une extension endocrinienne et même une lise osseuse. L'IRM va nous montrer les extensions au niveau des parties. Vous allez remarquer par exemple ici, on a une extension latérale qui se fait au niveau de la force intratemporale et qui remonte derrière le sinus maxillaire au niveau de la force intratemporale.

Et ça, c'est le rôle de l'IRM pour explorer les tissus humains. Alors, une fois qu'on a confirmé le diagnostic après une biopsie et qu'on l'imagine a permis de localiser l'extension tumorale, il faudra faire le bilan d'extension sous forme d'un scanner cervico-thoracique pour rechercher des métastases pulmonaires ou des métastases ganglionnaires qu'on n'a pas pu palper. On fera une échographie abdominale pour rechercher des métastases au niveau hépatique ou bien splénique.

Dans un certain temps, on fera des TEPS scanners ou des scintigraphies osseuses si on a des métastases ganglionnaires très importantes. Après, on réalisera un bilan très thérapeutique pour évaluer la fonction hépatique, la fonction rénale, la fonction cardiovasculaire, un examen de la somatologie avec une radio panoramique pour préparer le patient au traitement qui va être essentiellement basé sur la radiothérapie et sur la chimiothérapie. Alors, quels sont les diagnostics différentiels qui peuvent s'opposer devant ces tumeurs ou bien ces cancers du carbone ? D'abord, c'est l'hypertrophie des végétations adhéniées qui est une chose très fréquente chez l'enfant.

Mais les végétations en général ne se présentent pas sous forme de lésions bourgelantes. Il n'y a pas ce saignement qui peut se faire facilement au contact. En général, il n'y a pas d'adhéropathies métastatiques avec leur caractère dur, infiltrant et parfois fixé.

On arrive facilement à faire la part entre les tumeurs et les végétations adhéniées par l'examen endoscopique. Il y a certains tumeurs bénis auxquels il faudra penser, c'était le fibrome nasopharyngien. C'est un diagnostic auquel il faudra penser parce que lorsqu'on est devant un fibrome nasopharyngien, il ne faut pas faire de biopsie.

Donc, il faut absolument éliminer ce fibrome et c'est pour ça qu'on demande d'abord avant de faire la biopsie, faire une imagerie qui va nous montrer le CF de la tumeur. En cas de fibrome nasopharyngien, en général, ma tumeur est très vascularisée et ça permet d'éliminer déjà en imagerie la possibilité d'un cancer puisque le fibrome a certains caractéristiques en premier, c'est le caractère hypervasculaire. Les lymphomes ou bien la tuberculose du caverne ou bien les autres cancers en général, c'est l'anathromopathologie qui permet de faire la part, la différence avec les autres cancers, les autres carcinomes du caverne.

Alors, une fois qu'on a confirmé les diagnostics et qu'on a étudié un petit peu l'extension grâce à

l'acné à l'endoscopie et à l'imagerie, on pourra classer la tumeur selon la dernière classification de 2017, c'est donc l'expression TNM. Lorsque la tumeur est limitée au nasopharynx, c'est le T1. Lorsque la tumeur est étendue aux espaces parapharyngé et aux onisculites pterygoïdiennes et aux prévertébraux, c'est un T2.

Lorsque la tumeur est lente et les structures osseuses, c'est déjà un T3. Les structures osseuses, c'est-à-dire la base du crâne étant moyenne, âge antérieur, bien les cavités synergiques, c'est un T3. L'extension intracrânienne ou bien la teinte des nerfs crâniens de la glande parotide, de l'orbite ou de l'hypopharynx, ça, c'est déjà au stade T4.

Dans la classification des adénopathies, N0 lorsqu'on n'a pas d'envahissement ganglionnaire, chose qui reste quand même rare dans le carcinome du rhinopharynx. Lorsqu'on est devant une adénopathie unilatérale de moins de 6 cm, c'est le N1. Lorsqu'on est devant un envahissement ganglionnaire qui est bilatéral mais qui est toujours inférieur à 6 cm et au-dessus du rebord inférieur du cartilage cricoïde, c'est le N2.

Mais si on est devant une adénopathie qui n'est pas 6 cm de diamètre, ou bien si l'adénopathie est siége au-dessous du bord inférieur du cartilage cricoïde, ou bien arrive jusqu'au niveau de la clavicule, là, on est déjà au stade N3 de l'envahissement ganglionnaire. Lorsqu'on n'a pas de métastase, c'est le N0. On présente une métastase à distance, c'est-à-dire pulmonaire, osseuse, hépatique.

On parle de N+. Alors, comment on traite ces carcinomes du cavernes ? Là, on va parler juste de façon générale pour donner les principes. Comme on l'a dit, dans les cancers du cavernes, il y a des carcinomes qui sont les plus fréquents.

Et puis, il y a les autres types, les sarcomes, les lymphomes, les mélanomes. Ceux-là, on ne va pas en parler. On va parler dans le traitement surtout des carcinomes du cavernes.

Lorsqu'on est devant un UCNT, c'est-à-dire un carcinome indifférent, c'est du type nasopharynge, c'est des tumeurs qui restent quand même de bons pronostics au stade précoce, puisqu'ils restent très radiosensibles, et chimiosensibles. Alors, lorsqu'on est en stade T1, T2, en général, c'est une radiothérapie qui va se faire sur la tumeur et sur les angiolymphatiques. Donc, la radiothérapie va se faire sur la tumeur et sur les angiolymphatiques, puisqu'on est devant un carcinome qui est pré-lymphophile.

On pourra associer une chimio- radiothérapie lorsqu'on a des métastases angiolymphatiques qui sont très importants, qui sont assez avancés. Dans ce cas-là, on peut associer une chimio-radiothérapie, mais si on est devant une tumeur qui est assez évoluée avec des métastases à distance, dans ce cas-là, la chimio-thérapie est associée à la radiothérapie. La chirurgie n'a pas une grande place dans le traitement du carcinome du K1, puisque le siége est profond, l'accès reste difficile, l'extension tumorale vers la base du crâne, vers les espaces latéraux ne permet

pas de faire une exérèse complète et carcinologique, et dans ce cas-là, la chirurgie reste vraiment très limitée dans le traitement du carcinome du K1, et il est indiqué uniquement devant un reliquat ganglionnaire après une radiothérapie, c'est-à-dire qu'on a terminé la radiothérapie et que le patient présente toujours des reliquats, un résidu sous forme de métastases ganglionnaires au niveau cervical, dans ce cas-là, on peut proposer un curage ganglionnaire pour traiter ces reliquats.

Alors, qu'en est-il du pronostic ? Le pronostic, il est fonction du type histologique et du degré d'extension. Alors, le type histologique de la survie est deux fois plus élevé dans les carcinomes indifférenciés que dans les carcinomes différenciés, c'est-à-dire que même dans les carcinomes, la survie est différente, donc plus la tumeur est indifférenciée, plus elle répond à la radiothérapie et à la chimiothérapie, donc plus la survie est bonne. L'extension ganglionnaire est inférieure, c'est-à-dire au niveau du creux cisclaviculaire, et de mauvais pronostic.

Ainsi que l'ostéolyse basi-craniale. Donc ça, ce sont deux éléments qui sont de mauvais pronostic. C'est lorsqu'on a une tumeur bien différenciée, lorsqu'on a une extension ganglionnaire basse, c'est-à-dire cisclaviculaire, et lorsqu'on a une lise au niveau de la base du crâne.

Ce sont les trois éléments de mauvais pronostic. Et vous remarquez ici que dans les stades 1 et 2, c'est-à-dire que la tumeur est toujours au niveau du siège, est limitée au niveau du crâne-vente, ou bien elle s'étend aux parois du caverne, mais sans lise osseuse. Là, la survie à 5 ans, elle peut atteindre jusqu'à 90%.

Une fois le patient est traité, il faudra assurer une surveillance qui doit être régulière, prolongée. On réalise des examens endoscopiques par des nasophagoscopies. Au moindre doute, on fera des biopsies au niveau du caverne pour éliminer le risque d'avoir une récurrence ou une poursuite évolutive.

On fera des scanners, des IRN, c'est-à-dire des imageries, qui vont être répétées pour pouvoir comparer les différentes images radiologiques et pouvoir guetter la moindre apparition de récurrence tumorale.